Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca de Porto Alegre

Av. Otto Niemeyer, 2000 - Bairro: Tristeza - CEP: 91910001 - Fone: (51) 3259-3460 - Email: frpoaregtr1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004598-57.2021.8.21.6001/RS

AUTOR: JULIANO CAMPAO
RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Vistos.

I - Relatório:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JULIANO CAMPÃO em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Na petição inicial, a parte autora narrou, em síntese, que é segurado do Seguro Saúde, cartão nº 774446002682005, e portador de câncer raro identificado como GANGLIONEUROBLASTOMA (CID C47.9), localizado e com metástase no abdômen, tórax e ossos, com afetação de diversos órgãos, entre eles o pulmão, e sem condição de ser operado e receber radioterapia. Disse que apresentou progressão do tumor, tendo recebido mais de um ano de quimioterapia, que foi coberta pelo plano. Pontuou que realizou exame genético mais moderno existente para tentar identificar a mutação que fosse passiva de tratamento específico, chamado de Foundation, o qual identificou uma mutação no gene ALK, que se apresenta em apenas 5% nesse caso. Esclareceu que o médico assistente indicou como única opção possível de tratamento para sua enfermidade a medicação alectinibe (Alecensa) 150mg, 4 comprimidos, 2 x ao dia, no total de 1200mg ao dia. Discorreu acerca da urgência para o início do tratamento. Asseverou que a ré negou a cobertura sob a justificativa de que o tratamento não seria indicado para neoplasia do pulmão, conforme rol da ANS. Aduziu que formulou nova solicitação e que o pedido foi negado. Requereu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado à ré, no prazo de 3 (três) dias úteis, providenciasse o fornecimento da medicação alectinibe (Alecensa) na dose de 150mg, 4 comprimidos, 2 x ao dia, no total de 1200mg ao dia, com fornecimento enquanto durar o tratamento na forma da prescrição médica constante do laudo, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar e que fosse a ré condenada ao pagamento de danos morais. Pediu a gratuidade judiciária. Juntou documentos.

Em decisão proferida no evento 4, DESPADEC1 foi deferido o pedido de gratuidade judiciária e o pedido liminar.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (evento 17, CONT1). Em preliminar, impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, referiu que se trata de apólice do tipo EMPRESA SAÚDE EMPR - CIA 571 que tem como Estipulante a Empresa CWI SOFTWARE LTDA – apólice TÉCNICA. A apólice coletiva foi implantada em 01/12/2017; com inclusão do titular em 10/06/2021. Apontou que, em 08/10/2021, foi solicitada autorização de senha ambulatorial / SADT, pelo referenciado CLINIONCO, com vistas à realização de mudança de protocolo de tratamento quimioterápico de paciente portador de RABDOMIOSSARCOMA, através de TERAPIA ONCOLÓGICA - PLANEJAMENTO E 1° DIA DE TRATAMENTO com o medicamento ALECENSA. Salientou que foi negada a autorização sob o fundamento de que de acordo com o Rol da ANS e a bula Anvisa, o tratamento não era indicado para neoplasia de pulmão. Esclareceu que em 18/10 e em 27/10/2021 constaram outras solicitações de autorização em sistema, para tratamento com o quimioterápico de uso via oral domiciliar ALECENSA; também negadas pela Seguradora. Afirmou que a apólice em questão foi contratada na vigência da Lei n.º 9.656/98, estando vinculada, à cobertura prevista no Rol de Procedimentos da ANS. Disse que, o medicamento prescrito ao autor, ALECENSA (ALECTINIBE) não possui indicação de tratamento para a patologia que o acomete (GANGLIONEUROBLASTOMA METASTÁTICO). Discorreu acerca da inexistência de ilegalidade na negativa de cobertura. Pediu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Foi apresentada réplica (evento 24, RÉPLICA1).

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relatório.

II - Fundamentação:

Em respeito às partes e seus doutos procuradores, com base no princípio da transparência, registro que a Vara Cível do Foro Regional da Tristeza, composta por dois Juizados de Direito, é uma das unidades judiciárias que apresenta, além do maior número de processos em andamento na comarca de Porto Alegre, também o maior número de novos processos ajuizados todos os meses. Mensalmente, mais de 500 novas ações são ajuizadas nos 1º e 2º Juizados desta unidade, resultado do aumento populacional e da expansão econômica e imobiliária que vêm ocorrendo na Zona Sul desta Capital, potencializado pelos efeitos da pandemia nos últimos anos. Atualmente, em decorrência das digitalizações dos processos físicos para eletrônicos, conta-se saldo ínfimo de processos físicos, que se somam aos mais de 18.300 processos eletrônicos. Todos os processos novos e os cumprimentos de sentença já estão sendo distribuídos em forma eletrônica desde meados de 2019, via Sistema Eproc. Visando à prestação jurisdicional em prazos razoáveis, e norteados pela contínuo aperfeiçoamento dos serviços, estão sendo adotados despachos dinamizadores procurando antever etapas processuais de maneira a agilizar os respectivos cumprimentos pelo Cartório. Os Servidores do Cartório (1 gestor e mais quatro técnicos e estagiários), sem prejuízo de outras atribuições (cumprimentos de audiências, expedição de alvarás, atendimentos e orientações gerais), cumprem metas semanais de impulsionamento de pelo menos 1.100 processos conforme a ordem

cronológica, somando-se ao apoio que vem sendo prestado pela CCC - Central de Cumprimento Cartorário e a CCE – Central de Cumprimentos de Endereços. Em consequência dessa agilização, também resulta em número crescente, e invencível, de processos prontos para julgamento. Quanto mais rápido anda o processo, mais rápido ele fica pronto para sentença. Mesmo que cada Magistrado despache e impulsione cerca de 2000 processos por mês, presida dezenas de audiências e profira, no mesmo período, em média, cerca de 70 sentenças de mérito (sem contar as decisões liminares, homologações de acordo, decisões interlocutórias, etc.) o acervo de processos eletrônicos conclusos para sentença sempre tende a crescer, o que vinha sendo amenizado, recentemente, por Regimes de Exceção instituídos pela E. Corregedoria-Geral da Justiça, que encaminhava a julgamento para outros Juízes(as) os feitos que ultrapassassem os 60 dias de conclusão. Não obstante toda essa engenharia desenvolvida, impende que se reserve a Justiça Comum para os casos mais complexos, que não possam tramitar nos Juizados Especiais Cíveis, unidades judiciárias de tramitação informal, célere, e igualmente voltada à realização da Justiça. Feita essa longa mas necessária justificativa, e sempre disponível para esclarecimentos e resolução de eventuais problemas pontuais que se façam necessários (telefone Gabinete 2º Juizado: 51 3259-3514 Cartório: 51 3259-3508 e 51 3259-3509, WhatsApp 51 98059-1367), passo à fundamentação propriamente dita.

Rejeito a impugnação ao valor da causa arguida pela ré, em preliminar de contestação.

O pedido inicial formulado pela parte autora limita-se à obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento da medicação alectinibe (Alecensa) na dose de 150mg, 4 comprimidos, 2 x ao dia, no total de 1200mg e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, em que pese a parte autora não tenha indicado na petição inicial o valor referente ao pleito indenizatório, o valor atribuído à causa, de R$ 30.000,00, correspondeu a quantia atinente ao tratamento médico postulado.

Diante de tais fatos, rejeito a impugnação.

No caso em concreto, além das normas de Direito Civil, o contrato em comento está sob a égide da Lei nº 8.078/91, pois a relação entre as partes é típica de consumo, na forma de seus arts. 2º e 3º do CDC.

Desse modo, e aliado à hipossuficiência processual da parte autora, a inversão do ônus probatório é medida que se aplica, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, o que não afasta, no entanto, a regra do art. 373, I, do CPC.

A questão está pacificada no enunciado sumular nº 608 do STJ*:*

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Este também é o entendimento do Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ***PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.*** *ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização a título de danos morais, na qual a parte autora objetiva a condenação da demandada ao* ***fornecimento*** *das sessões de Eletroconvulsoterapia a qual foi negado pela demandada, julgada procedente na origem.* ***Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do seu artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998.*** *As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. Ressalte-se, outrossim, que é facultado aos planos de saúde estabelecerem para quais patologias irão oferecer cobertura; no entanto, não podem limitar o* ***tratamento*** *delas, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico. Precedentes do e. STJ e desta c. Câmara Cível. No presente caso, discute-se a licitude da negativa de cobertura de eletroconvulsoterapia, alicerçada em não estar previsto o procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, conforme atualização pela Resolução Normativa nº 387/2016 da ANS. É incontroverso que a parte autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela operadora ré e que a enfermidade que a acomete — Transtorno Depressivo Recorrente — é contratualmente coberta. Assim, analisando o* ***tratamento*** *postulado pela parte autora em específico (cobertura de eletroconvulsoterapia), verifica-se que é de cobertura obrigatória, porquanto prescrito pelo médico assistente para* ***tratamento*** *de patologia coberta pelo plano de saúde , cabendo destacar, inclusive, a ausência de resposta com o* ***tratamento*** *farmacológico. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083426650, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 20-02-2020)*

Decorre daí que a interpretação das cláusulas contratuais, notadamente nos contratos de adesão, deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor, firmada nos princípios de proteção, tal como previsto no art. 47 do CDC. Releva, no caso, o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, como adiante se desenvolve.

No caso dos autos, o rol de procedimentos da ANS estabelece as coberturas mínimas obrigatórias, como medicamentos, consultas e procedimentos médicos, pré-estabelecidos com uma base na qual os planos de saúde são obrigados a cobrir. É garantido ao médico que assiste ao autor recomendar o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

De outro lado, este Juízo vem entendendo que cabe ao Plano de Saúde suportar os custos imediatos do procedimento, segundo os valores constantes do procedimento previsto na lista da ANS, dentro dos parâmetros contratuais estabelecidos entre as partes, e depois cobrar do paciente contratante eventuais diferenças.

Novos métodos de tratamento e medicamentos que são desenvolvidos com o auxílio da tecnologia, quando mais onerosos, podem deixar de ser garantidos pelos plano de saúde quando não previstos contratualmente.

Porém, afigura-se abusiva a negativa da operadora de saúde quando recomendado pelo médico assistente a utilização do medicamento indicado na petição inicial.

Ademais, o STJ tem entendido pelo fornecimento de medicamentos devidamente registrados pela Anvisa, quando seu uso resultar comprovado por laudo médico. (Aresp 1534208 RN 2019/0192917-2).

Outrossim, o direito de saúde pública tutelado robustece o direito à vida digna do autor, que não pode ter sua chance de tratamento e de cura rechaçada quando o tratamento foi devidamente prescrito por médico especialista, ainda que não descrito nos exatos termos da listagem genérica de órgão público, em estrita consonância com os preceitos constitucionais.

Nesse sentido:

> *Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do **direito à vida**, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.*

Se não bastasse isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte ré decidiu pela manutenção da decisão proferida em sede de tutela de urgência, nos seguintes termos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DE GANGLIONEUROBLASTOMA. MEDICAMENTO ALECTINIBE (ALECENSA). ROL DA ANS TAXATIVO, QUE NÃO SE APLICA PARA OS MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PRESCRITOS SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 1) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 2) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, esta Câmara concluiu por rever posicionamento e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR, sobretudo considerando que o referido rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes. 3) Não obstante, no julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, atestou que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica). 4) Caso dos autos em que, além de se tratar de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento de GANGLIONEUROBLASTOMA (CID C47.9), localizado e com metástase no abdômen, tórax e ossos, com afetação de diversos órgãos, entre eles o pulmão, e sobretudo porque o autor não tem condições de ser operado ou receber radioterapia, o fármaco Alectinibe (Alecensa) ainda está previsto na Diretriz de Utilização da ANS de nº 64 / RN 465 para tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK). 5) Mantida a decisão de origem, que deferiu pedido de tutela de urgência, por fundamentos diversos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 52321208520218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)*

Diante de tais fatos, prospera o pedido, devendo a ré ser condenada ao fornecimento do tratamento consubstanciado no fornecimento da medicação alectinibe (Alecensa) na dose de 150mg, 4 comprimidos, 2 x ao dia, no total de 1200mg ao dia ao autor, com fornecimento enquanto durar o tratamento, na forma da prescrição médica constante do laudo.

No mesmo sentido, assiste razão à parte autora no que se refere à condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, concluiu que a negativa desmotivada do plano de saúde configurou abalo moral indenizável, já que contribuiu para o agravamento do estado de aflição psicológica e de angústia do usuário, que já se encontra abalado e com a saúde debilitada:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. TEMA 1069. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura dos procedimentos necessários a complementação do tratamento da obesidade, visto que perdeu uma grande quantidade de peso e necessita de procedimentos relativos a reparação em razão de sobras de pele, postulando, também indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, na origem. No caso dos autos, discute-se a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. No julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.069/STJ, restou firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça as seguintes teses, sic: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.Incontroverso nos autos a relação contratual entre as partes, bem como a necessidade da realização dos procedimentos postulados pela parte autora, tendo em vista o laudo médico acostado no evento 3 procjudic1 fl. 35/50, através do qual restou comprovada a necessidade das seguintes cirurgias: dermolipectomia abdominal; correção de diástases da parede abdominal; correção de lipodistrofia braquial a direita; correção de lipodistrofia braquial a esquerda; dermolipectomia dorsal e em flancos; lipoescultura; enxerto composto em glúteos esquerdo/direito; lipoaspiração em dorso, trocanter e interno das coxas e plástica mamária/reconstrução com prótese.Em que pese a norma do art. 10, inc. II, da Lei nº 9.656/1998, excluir da cobertura dos planos de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, o caráter reparador ou funcional, em paciente pós-cirurgia bariátrica, constitui desdobramento da primeira cirurgia, de caráter fundamental à recuperação integral da saúde do usuário acometido de obesidade mórbida. Cobertura devida nos termos dos repetitivos do egrégio STJ.A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde restou justificada, vez que baseada em interpretação de cláusula contratual, situação que afasta agir ilícito, passível de indenização.DUPLA APELAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS(Apelação Cível, Nº 50016791920188210014, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024)*

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PLANO DE SAÚDE. RECUSA À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/201 6: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

*2. **Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base em dúvida razoável**.*

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar a conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1927347/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Assim, condeno a parte ré ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos incidentes desde a citação.

III - Dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos autos da ação ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JULIANO CAMPÃO em face de BRADESCO SAÚDE S/A., a fim de tornar definitiva a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte ré providencie, no prazo de 03 dias, o fornecimento da medicação alectinibe (Alecensa) na dose de 150mg, 4 comprimidos, 2 x ao dia, no total de 1200mg ao dia ao autor, com fornecimento enquanto durar o tratamento, na forma da prescrição médica constante do laudo, sob pena de multa diária, bem como condenar a parte ré ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 8.000,00, acrescidos de consectários legais, nos termos da fundamentação supra.

Diante do resultado do julgamento, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observados os critérios constantes do art. 85, § 2º, do CPC.

Caso sobrevenham Embargos de Declaração, intime-se a parte adversa para contrarrazões. Depois, voltem para julgamento.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Depois, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitando em julgado, e caso depositado o valor da condenação, expeça-se alvará à parte autora. Desde já, fica a parte ré ciente que o não pagamento do débito em até 15 dias da intimação do despacho que vier a receber o pedido de cumprimento de sentença, além dos encargos supramencionados, ensejará a aplicação de multa de 10% sobre o valor do débito total, mais novo percentual de honorários advocatícios, no percentual de 10% também sobre o valor total do débito, tudo com base no § 1º do art. 523 do CPC.

Por fim, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **VANDERLEI DEOLINDO, Juiz de Direito**, em 27/3/2024, às 0:27:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10057151982v5** e o código CRC **301f5545**.